פרוטוקול טיפולי בפצעים (סל חבישות מתקדמות מתעדכן אחת לשנה מעודכן 12/2025)

מצעי לחץ

תאור/סוג החבישה	שם המוצר		דרגה ותיאור הפצע :	תדירות החלפת חבישה	צורך בחבישה משנית
חבישות ספוג=FOAM (להפרשות מרובות)	Permafoam		2,3,4	פעם ב 2-3 ימים לפי כמות ההפרשות	לא
	Tielle		2,3,4	פעם ב 2-3 ימים לפי כמות ההפרשות	לא
	Hydrotac		2,3,4	פעם ב 2-3 ימים לפי כמות ההפרשות	לא
חבישות שאינן נדבקות - Low Adherent	Gaza Vazeline (חבישת גזה מצופה בוזלין)		1,2	פעם ביום	כן
	Paranet (חבישת גזה מצופה בשמן פאראפין)		1,2	פעם ביום	כן
	Actilite [חבישת גזה מצופה בדבש ושמן מנוקה]		1,2	פעם ב 2-3 ימים	כן
	Inadine (חבישת גזה מצופה ביוד)		2,3	לפחות פעם ביום לפי שינוי צבע החבישה המבהירה	
חבישות שקופות - FILM	Op –site		1,2	פעם ב 1-3 ימים לפי כמות ההפרשה	לא
	Tegaderm		1,2	פעם ב 2-3 ימים	לא
	Biofilm		1,2	פעם ב 2-3 ימים	לא
חבישות - Hydrocolocoids	Hydrocoll		2,3	פעם ב- 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	לא
	Granouflex		4,5,6	פעם ב- 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	לא
חבישות אצות ים = Alginate	Sorbalgon		2,3	פעם ב- 2 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	כן
	Silvercel Ag (אצות ים עם יוני כסף)		2,3,4	פעם ב – 1 עד 4 ימים לפי כמות ההפרשה	כן
	Flaminal Hydro (אלגינוג'ל)		2,3,4,5	פעם ב- 1 עד 4 ימים בהתאם לצורך	כן
	Flaminal Forte (אלגינוג'ל)		2,3,4,5	פעם ב- 1 עד 4 ימים	כן
חבישות למניעת ריח (עם פחם פעיל)	Actisorb		3,4	פעם ב-2 עד3 ימים	כן

מצעי לחץ

תאור/סוג החבישה	שם המוצר		דרגה ותיאור הפצע :	תדירות החלפת חבישה	צורך בחבישה משנית
חבישות וחומרים אנטי-מיקרוביאלים	Silverol (אנטי פטריתי מקבוצת סולפונאמידים)		2,3,4	פעם ב – 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה . אין להשתמש בפנים ורגישים ל-G6PD	כן
	Aquacel Ag (מבילה בסף)*		2,3,4	פעם ב 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	כן
	Mafenide Acetate 8.5%		2,3,4,5	פעם ביום	כן
	K SEPT (troclosene " sod) 1000mg כדור ל 1 ליטר מים "		2,3,4,5	"פעמיים ביום (2) Tablet in 1 L. water provides 1000ppm LAC (Latent (Available Chlorine Good for use for 48 "hours	כן
חבישה הידרופילית (עם אבץ + ויטמינים A B6-1)	Dermagran B		1,2	פעם ביום	כן
חבישת - הידרוג'ל (עם אבץ וויטמין B)	Dermagran Gel		2,3,4,5	פעם ביום	כן
חבישות קולגן	Promogran*		2,3,4,5	עד להפיכה לג'ל במגע עם הפרשות	כן
נוזל איזוטוני	Sol Hartman		2,3,4,5	עד 3 פעמיים ביום	כן
	Sol Nacl 0.9%		2,3,4,5	עד 3 פעמיים ביום	כן
חבישת הגנה	Biafine		1,2,3,4,5	בזמן חבישה מסביב לפצע	כן
	Zincod				
	Inotiol				
קומפרסים	Magnocare 33%		לבצקות	עד 3 פעמים ביום למשך 20 דקות	כן
חבישה ביולוגית	דבק ביולוגי		דרגה 1	לפי שיקול מיקצועי	לא
	Dermaden		2,3,4,5	עד 3 פעמים ביום	כן

מצעים סופגים

תאור/סוג החבישה	שם המוצר		דרגה ותיאור הפצע :	תדירות החלפת חבישה	צורך בחבישה משנית
טכנולוגיות מתקדמות	VAC – טופס 1ז של הקופה			החלפה בתדירות הנקבעת על ידי נציג החברה המספקת את הטכנולוגיה	לא
הטרייה בירורגית	פעולה המורשת לביצוע: רופא, אחות מומחית קלינית פצע וסטומה (חוזר מינהל הסיעוד 203/2023)		3,4,5,6	לפי שיקול מיקצועי	
חבישות שאינן נדבקות - Low Adherent	Gaza Vazeline (חבישת גזה מצופה בוזלין)		1,2,3	פעם ביום	
	Paranet (חבישת גזה מצופה בשמן פאראפין)		1,2,3	פעם ביום	כן
	Actilite [חבישת גזה מצופה בדבש ושמן מנוקה]		1,2,3	פעם ב- 2 עד 3 ימים	כן
	Inadine (חבישת גזה מצופה ביוד)		1,2,3	לפחות פעם ביום לפי שינוי צבע החבישה המבהירה	כן
חבישות וחומרים אנטי-מיקרוביאלים (הידרופייבר)	Aquacel Ag (מבילה בסף)		דרגה 2+3	פעם ב- 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	
חבישות ספוג=FOAM (להפרשות מרובות)	Permafoam		דרגה 2+3	פעם ב- 2 עד 3 ימים	לא
	Tielle		דרגה 2+3	פעם ב- 2 עד 3 ימים	לא
	Hydrotac		דרגה 2+3	פעם ב- 2 עד 3 ימים	לא
חבישת -הידרוג'ל (עם אבץ וויטמין B)	Dermagran Gel		דרגה 2+3	פעם ביום	כן
חבישות - Hydrocolocoids	Hydrocoll		דרגה 3	פעם ב – 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	לא
	Granouflex		דרגה 3	פעם ב- 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	לא

איך מציגים פצע לייעוץ ?

תמונה ברורה , מוארת ובפוקוס של הפצע
- אחרי ניקוי
- תמונה של הפצע כשליש מהפריים ושל האיבר ההיקפי
- במה מטופל ומשך הטיפול

רקע כללי ומצב תפקודי
- גיל , מין, מסגרת מטפלת, סטאטוס תפקודי , אלרגיות.
- ממצאי מבחן גורטון, ניידות ומעברים.
- מצב הכרה, מצב נפשי ויכולת לטיפול עצמי ושיתוף פעולה.
- פצע לחץ בעבר.
- פצע ללא שיפור למשך זמן 2-4 שבועות .

אמצעים למניעת פצע
- משטחי תמיכה, שינוי תנוחה, טיפוח עור, תוספי תזונה.
- אמצעי מניעת פצעי לחץ בעקב, ממכשור , חבלה, בריחת שתן וצואה.

גורמי סיכון חיצוניים
- מכאניים-כוחות לחץ, חיכוך, גזירה ורטיבות.
- סביבתי.

גורמי סיכון פנימיים
- מחלות סיסטמיות : סכרת , מחלת כלי דם פריפרית.
- טיפולים המדכאים מערכת החיסון: סטרואידים, כימותרפיה, קרינה וכדומה.
- תרופות, הידרציה ותזונה.
- ערכי מעבדה כימיה וספירה לא תקינים.

מיטת הפצע

T - רקמה שחורה - אינה חיונית יבש ונמקי - הטרייה והרטבה
I - פצע צהוב - דיהום או דלקת - נקה אותו
M - פצע מפריש - איזון הפרשות ושמירה על לחות
E - פצע אדום - שוליים ואפיתליזציה - הגן עליו והסר לחץ

מקראה
דירוג הפצעים:

דרגה 1
NONBLANCHABLE ERYTHEMA / אדמומיות לא ניתנת להלבנה לאחר לחיצה.



דרגה 2
PARTIAL THICKNESS אובדן עובי חלקי של דרמיס מתבטא בשטפון, שלפוחית או פצע שטחי עם גבולות ברורים או מפרישי , פיהו עם גרנולציה ואפיטליזציה בשלב "האחרון", אזור וחום מקומי



דרגה 3
FULL THICKNESS SKIN LOSS / אובדן עובי מלא של רקמות. מתבטא במיצע מקק(קריטים) ורוחב , בשלב "אחרון" מפריש, חריף ריח רע או ארוחי הצריה בשלב גרנולרה ואפיטליזציה, פצע בשלב היפרגרנולרה (שפוני יתר).



דרגה 4
FULL THICKNESS TISSUE LOSS / אובדן רקמות בעובי מלא עם עצם, גיד או שריר חשופים



5
UNSTAGEABLE /UNCLASSIFIED: full-thickness skin or tissue loss-depth unknown אובדן עובי מלא של עור או רקמות - עומק אינו ידוע. מתבטא במיצע הנמוכות גלד בצבע שחור.



6
SUSPECTED DEEP TISSUE INGURY-depth unknown / חשד לפציעה ברקמות עמוקות מתבטא בצבע עם רקמות עור בצבע כחול/סגול/אפור קרה ונוקשה



מאיה שקולניק גזית –
מרפ"ג בית הדר באשדוד, 2025.

חתימת מנהל/ת רפואי/ת :

חתימת מנהל/ת שרותי האחיות :

